

VÓLVULO DE SIGMA

Victoria Cano López. Rubén Pérez Fernández. Carlos Chávez Flores. Julio Tito Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

El vólvulo de colon se define como una torsión del intestino grueso sobre su eje mesentérico ocasionado así un cuadro de oclusión intestinal. Es la tercera causa de oclusión intestinal en adultos (10-15%). El vólvulo sigma representa la forma más frecuente, en un 60-70% de los casos. Esta patología incide principalmente en pacientes de edad avanzada, pluripatológicos e institucionalizados; siendo necesario un correcto diagnóstico y tratamiento precoz para resolver el cuadro sin complicaciones.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico se realiza a partir de criterios clínicos, radiológicos, endoscópicos y en ocasiones, el diagnóstico es intraoperatorio. La aproximación diagnóstica en estos pacientes en urgencias debe comenzar con una correcta anamnesis y exploración física.

Anamnesis

- Factores de riesgo (Tabla 1).
- Clínica de oclusión intestinal (vómitos, distensión abdominal, dolor abdominal, disminución de la expulsión de heces y gases).
- Según la rapidez de la torsión intestinal la clínica será más o menos grave.

Factores de riesgo
Sexo varón
Edad avanzada
Estreñimiento crónico
Enfermedades neurológicas o psiquiátricas
Cirugía abdominal previa.
Embarazo
Diabetes
Vólvulo previo

Factores de riesgo. Tabla 1

Exploración física.

- **Inspección:** estado general. Constantes. Coloración. Distensión abdominal. Actitud del paciente. Cicatrices de cirugías previas. Hernias.
- **Auscultación:** los ruidos intestinales pueden estar disminuidos o ausentes en caso de una obstrucción evolucionada o íleo paralítico o ser “metálicos” en caso de obstrucción de reciente comienzo.
- **Palpación:** se debe empezar por el sitio más alejado de donde el paciente refiera el dolor e ir comenzando desde palpación superficial a profunda buscando signos de irritación peritoneal y masas.
- **Percusión:** el abdomen suele ser timpánico.

Pruebas complementarias.

- **Hemograma.**
- **Bioquímica** con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, GGT, LDH, amilasa, bilirrubina, PCR/PCT.
- **Coagulación básica.**
- **Radiografía de abdomen:** la prueba de imagen de elección en primer lugar. Se observa una marcada dilatación intestinal con niveles hidroaéreos y la imagen denominada “en grano de café”, presente en un 30-60% de los casos (Figura 1). Permite el diagnóstico hasta en un 70% de los casos.

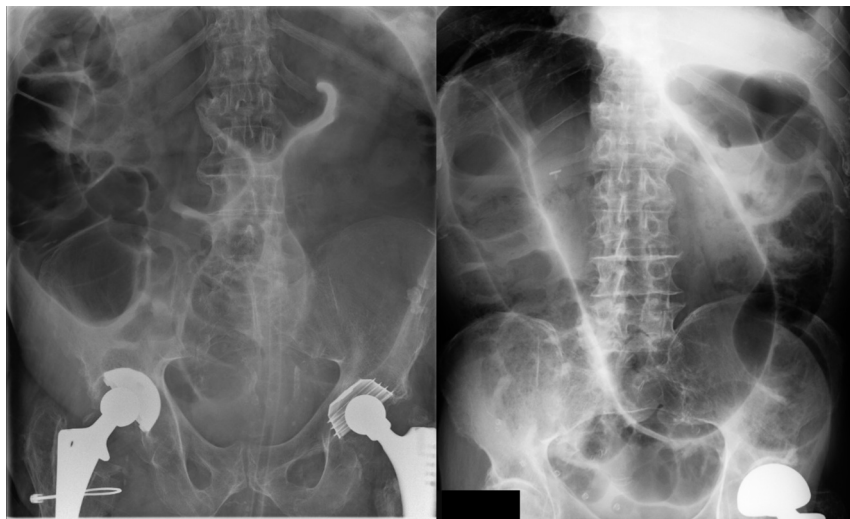


Figura 1: Radiografía de abdomen con la imagen típica “en grano de café”.

- **Enema opaco:** antiguamente usado para confirmar el diagnóstico, actualmente su uso está desaconsejado.
- **TAC abdominal:** en caso de dudas tras realización de radiografía, es la prueba de imagen con mayor rentabilidad diagnóstica (>90%). Muestra las asas intestinales dilatadas y su pedículo vascular enrollado en espiral. Además permite valorar la gravedad, como la isquemia de la pared, y descartar otras causas de oclusión intestinal.

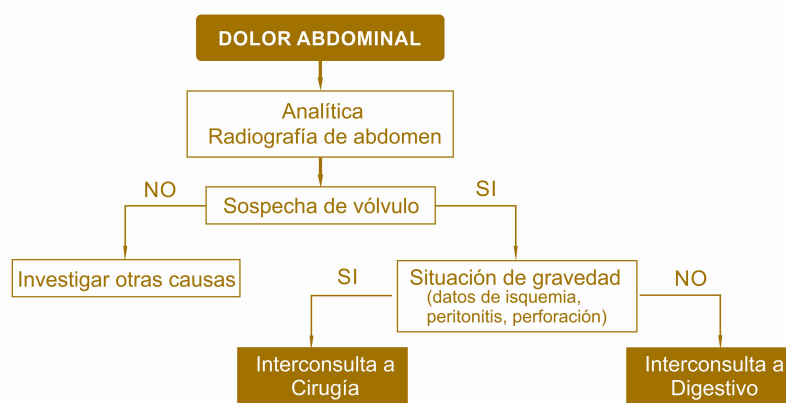


Figura 2: Algoritmo diagnóstico.

TRATAMIENTO

- **Medidas generales:** Dieta absoluta, sueroterapia, canalizar una vía venosa periférica, sonda nasogástrica (SNG) si sospecha de obstrucción, analgesia y antibiótico si peritonitis.

- Dieta absoluta
 - Sueroterapia
 - Canalizar una vía venosa periférica
 - Sonda nasogástrica (SNG) si sospecha de obstrucción
 - Analgesia iniciar con paracetamol 1 gr IV, luego según escala del dolor.
 - Antibiótico si peritonitis.
- **Colonoscopia:** Debe practicarse ante la sospecha clínica y radiológica siempre que no existan signos de peritonitis secundarios a isquemia o perforación del colon. Permite confirmar el diagnóstico y tiene papel terapéutico (figura 3). Puede colocarse sonda rectal con extremo proximal por encima del vólvulo. La efectividad terapéutica es de un 70-90% pero con una recurrencia del 18-90% por lo que sería recomendable valoración por la especialidad para cirugía electiva una vez resuelto el cuadro agudo.



Figura 3: Imagen endoscópica en “reloj de arena” compatible con vólvulo intestinal.

- **Cirugía urgente:** Si la colonoscopia no ha sido efectiva o el paciente presente signos de peritonitis, isquémica o perforación.

Puntos clave

- Alta sospecha diagnóstica ante paciente varón, de edad avanzada, con estreñimiento y antecedente de vólvulo previo.
- La clínica y la radiografía de abdomen tienen alta rentabilidad diagnóstica.
- La colonoscopia es la técnica terapéutica de elección siempre que no exista peritonitis, isquemia o perforación.

BIBLIOGRAFÍA

- Mulas C, Bruna M, García-Armengol J, Roig JV. Manejo del vólvulo de colon: Experiencia en 75 pacientes. Rev Esp Enferm Dig. 2010;102(4):239- 248.
- Perrot L, Fohlen A, Alves A, Lubrano J. Management of the colonic volvulus in 2016. J of Visc Surg. 2016;153(3):183-192.
- Codina Cazador A, Farres Coll R, Olivet Pujol F, Pujadas de Palol M, Martín Grillo A, Gomez Romeu N et al. Vólvulo de colon y recidiva del vólvulo: ¿qué debemos hacer?. Cir Esp. 2011;89(4):237-242.
- Scharl M, Biedermann L. A symptomatic coffee bean: acute sigmoid volvulus. Case Rep Gastroenterol. 2017;11(2):348-351.
- De la Peña García J, Terán Lantarón A, Arias Loste MT. Obstrucción intestinal baja. Medicina- Programa de Formación Médica Continuada Acreditado. 2012;11(7):407-412.

- Villacres Estrada D, Vigara García M. Vólvulo de sigma en nonagenarios: diferente actitud terapéutica, distinta evolución. Rev Esp Geriatr y Gerontol. 2018;53(S1):143.